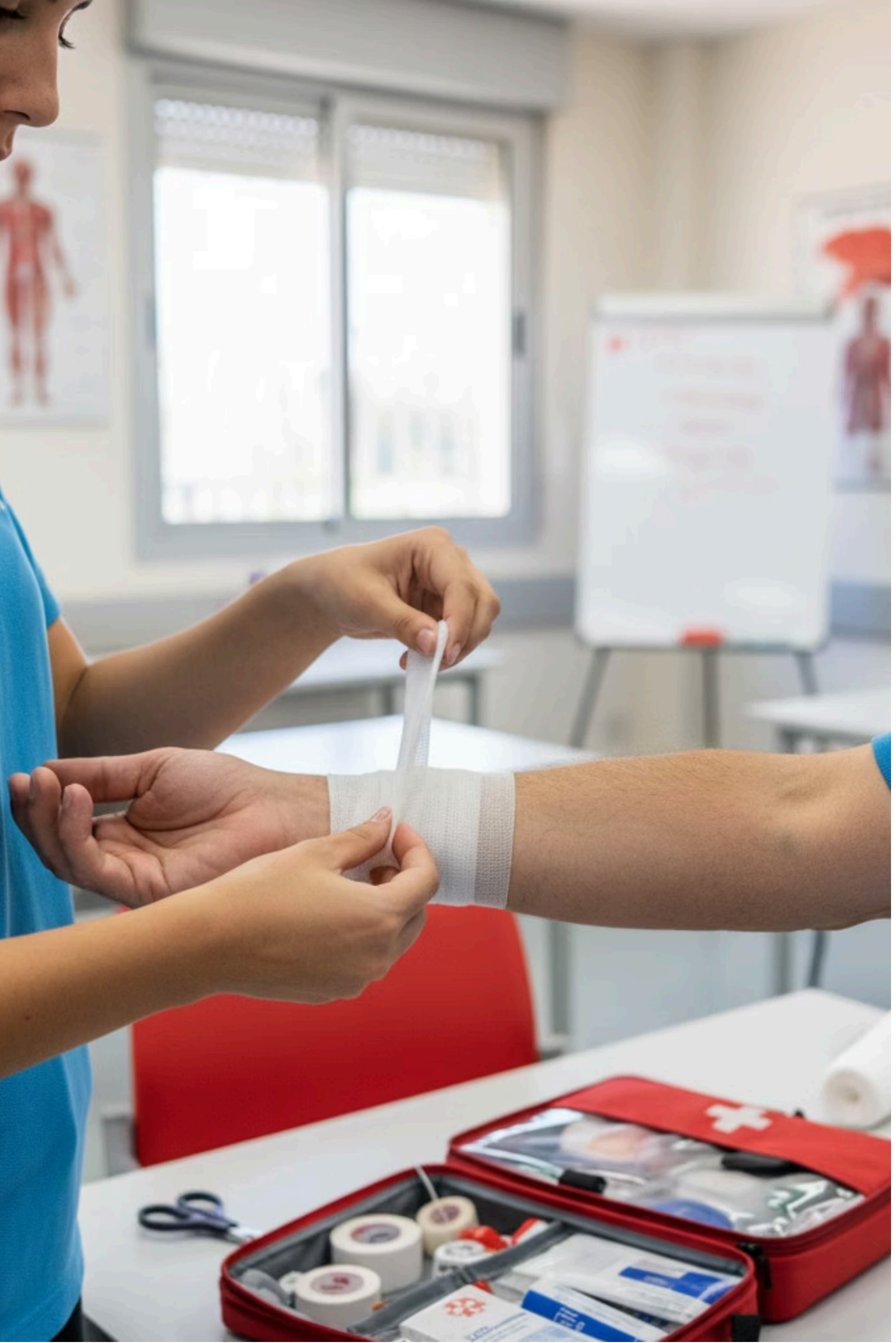
מצגת קורס עזרה ראשונה

קורס 44



עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

מהי עזרה ראשונה?

עזרה ראשונה היא מתן סיוע מיידי לאדם שנפגע או חלה בפתאומיות, עד להגעת צוות רפואי מקצועי.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

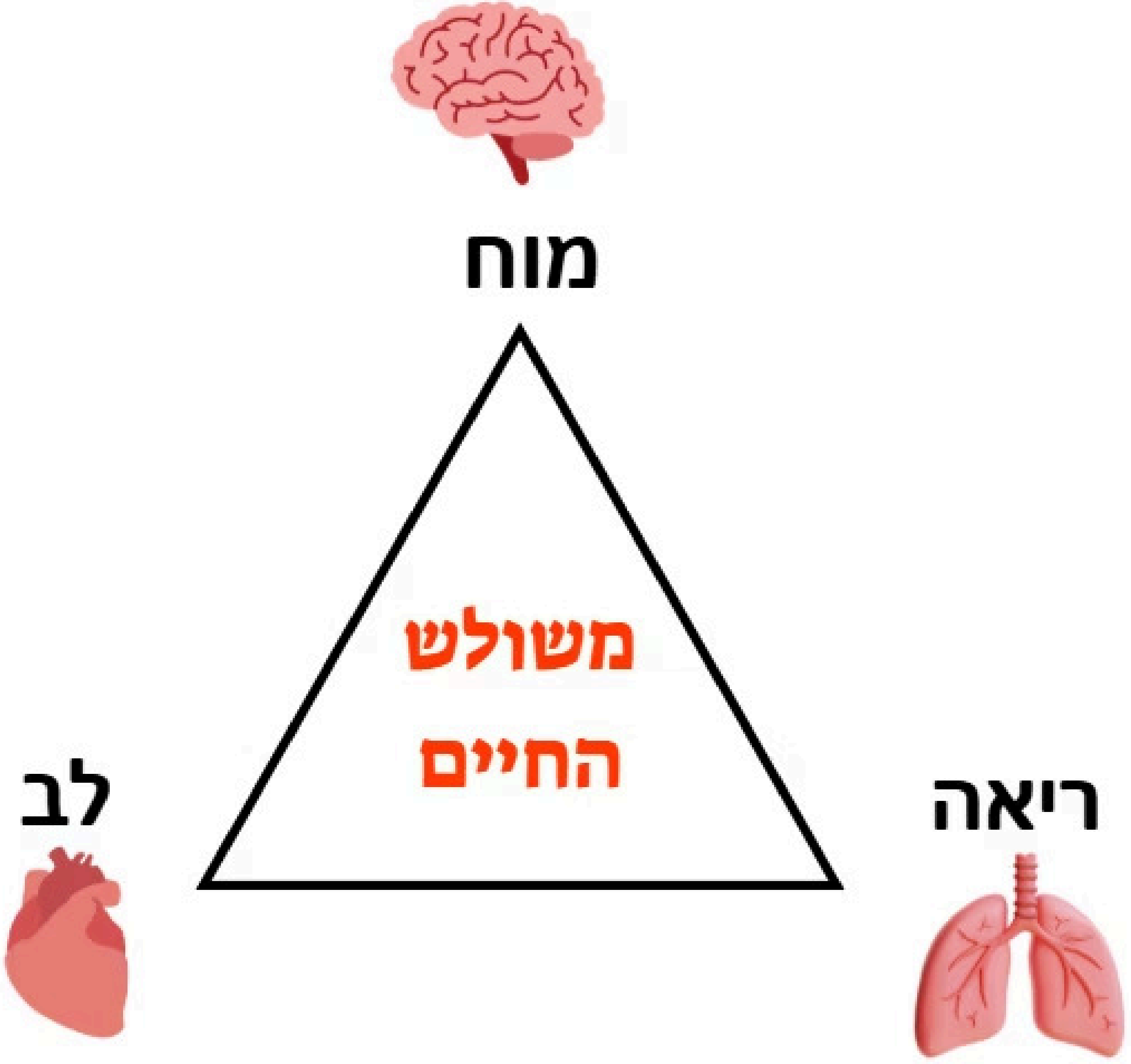
מטרות עזרה ראשונה

1
תמיכה ראשונית
סיוע עד קבלת טיפול רפואי מתקדם

2
מניעת החמרה
עצירת התדרדרות המצב והגנה על הנפגע

3
הצלת חיים
מתן טיפול מיידי שיכול להציל את חיי הנפגע

חשוב לזכור: עזרה ראשונה יכולה לעשות את ההבדל בין חיים ומוות ולמנוע נזקים בלתי הפיכים. כל שנייה קריטית במצבי חירום.


מוח
משולש
החיים
לב
ריאה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

משולש החיים

משולש החיים מייצג את שלושת האיברים החיוניים ביותר לקיום החיים: **המוח**, **הלב** וה**ריאות**. פגיעה באחד מהם מהווה סכנת חיים מיידית.

האיברים החיוניים

הלב

משאבת הדם - מזרים דם וחמצן לכל הגוף

הריאות

מערכת הנשימה - מספקות חמצן ומסלקות פחמן-דו-חמצני

המוח

מרכז השליטה - מנהל את כל תפקודי הגוף

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

המוח - מרכז השליטה

תפקודים עיקריים

- **שליטה על תפקודים חיוניים אוטומטיים**: נשימה, קצב הלב, ויסות חום הגוף ולחץ הדם
- **תפקודים קוגניטיביים**: חשיבה, למידה, זיכרון, קבלת החלטות ותחושת רגשות
- **מערכת מוטורית**: שליטה על תנועות רצוניות ובלתי רצוניות

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

חשיבות אספקת החמצן למוח

20%

צריכת חמצן

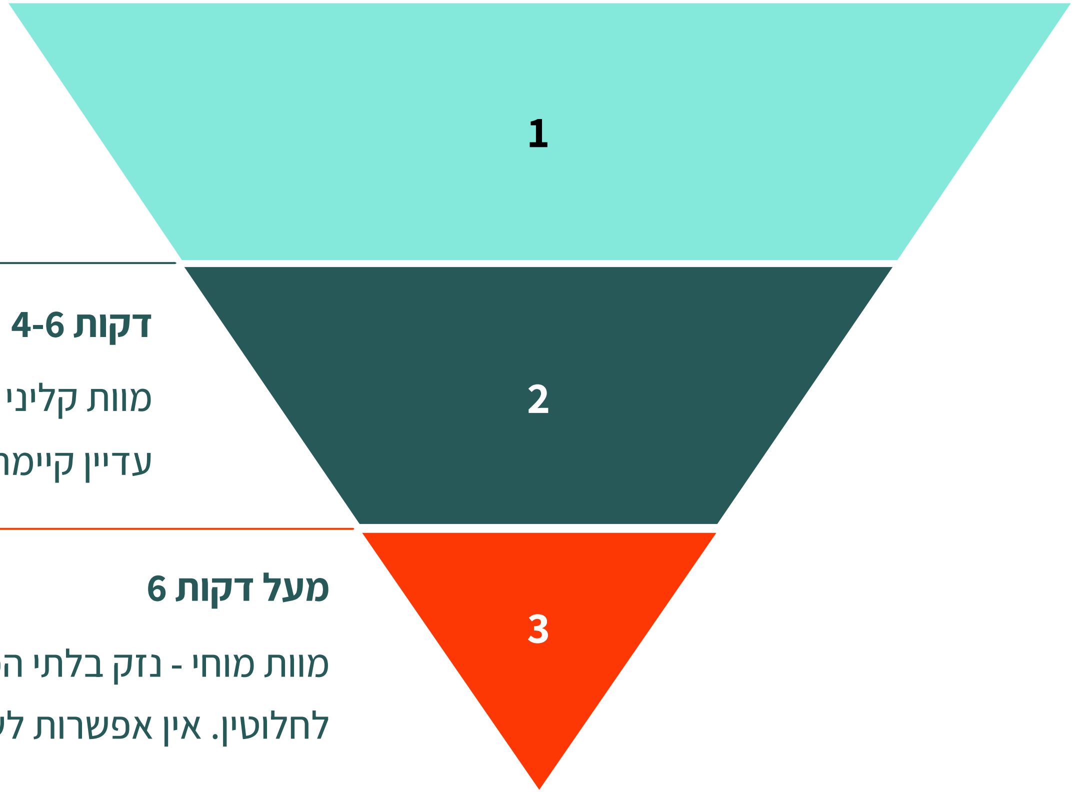
המוח צורך 20% מכלל החמצן בגוף, למרות שמהווה רק 2% ממשקלו

4-6

דקות קריטיות

תוך 4-6 דקות ללא חמצן, המוח מתחיל לסבול מנזק תאי בלתי הפיך

נזק מוחי מחוסר חמצן



שניות ספורות

ירידה בתפקוד המוחי - הפעילות המוחית תתחיל להיפגע

דקות 4-6

מוות קליני - הפעילות המוחית מפסיקה באופן זמנית, אובדן הכרה והפסקת נשימה.
עדיין קיימת אפשרות להציל את המוח באמצעות חידוש מהיר של אספקת החמצן

מעל דקות 6

מוות מוחי - נזק בלתי הפיך למוח. תאי המוח מתחילים למות והמוח מאבד את היכולת לתפקד לחלוטין. אין אפשרות לשחזר את התפקוד המוחי

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

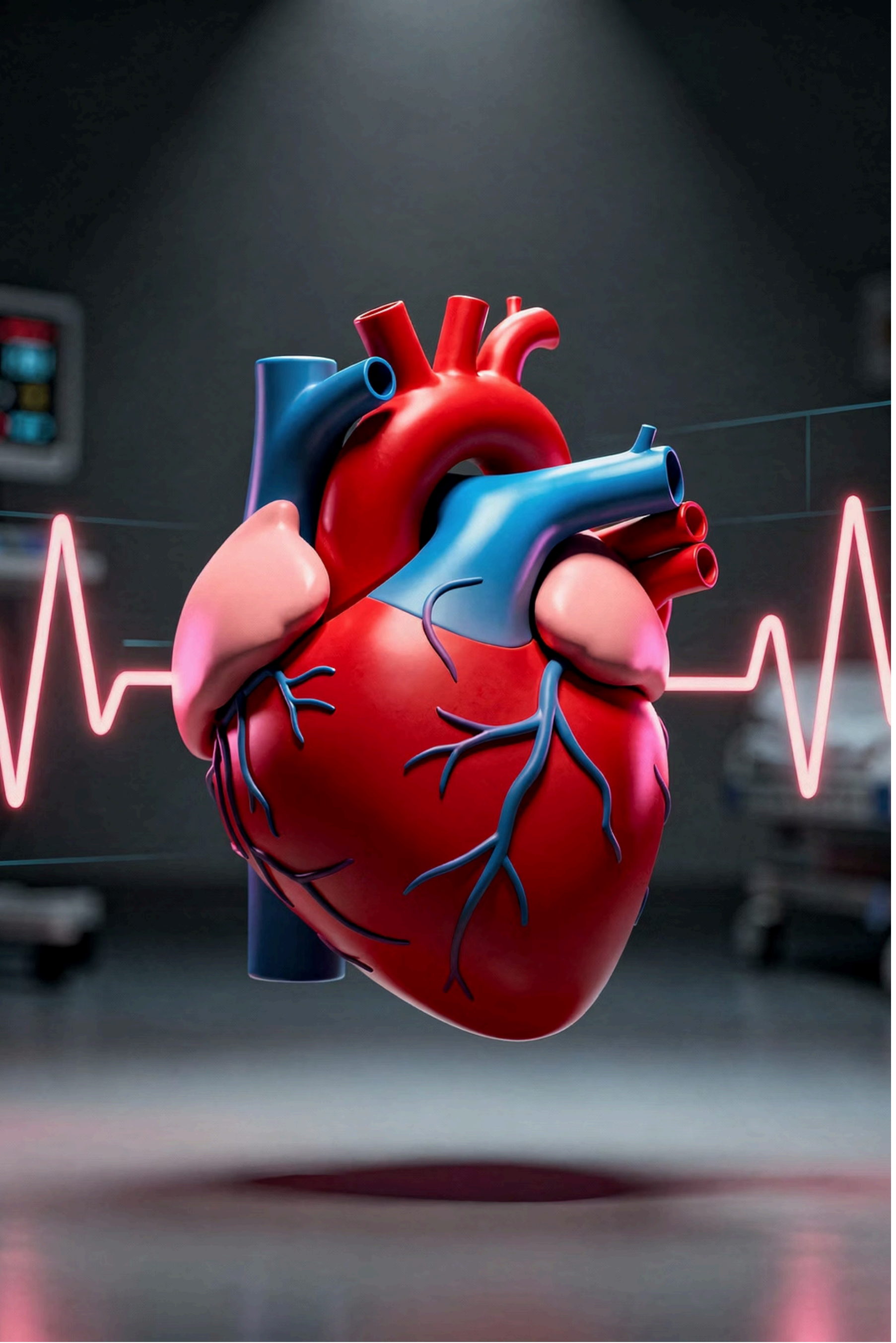
השפעות נוספות של נזק מוחי

פגיעה בתפקודים קוגניטיביים
חשיבה, זיכרון ולמידה

פגיעה מוטורית
קושי בתנועות מוטוריות

אובדן הכרה
תרדמת ממושכת

מוות מוחלט
הפסקת פעילות מוחית



עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

הלב - במערכת הגוף

תפקודים עיקריים

- שאיבת דם והזרמתו באופן מתמשך לכל חלקי הגוף
- אספקת חמצן וחומרים מזינים לתאים ולרקמות
- סילוק פסולת מטבולית ופחמן דו-חמני מהרקמות
- שמירה על זרימת דם תקינה וקבועה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

קצב הלב התקין

מבוגרים

60-100 פעימות לדקה במנוחה

יכול לעלות בזמן פעילות גופנית או במצבי לחץ

תינוקות וילדים

100-160 פעימות לדקה

קצב גבוה יותר לתמיכה בתהליכי גדילה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

דום לב והשלכותיו

דום לב מתרחש באופן פתאומי או כתוצאה מפגיעה באחת או יותר ממערכות הגוף. במצב של דום לב, החמצן לא מגיע למוח ולאיברים חיוניים, מה שגורם לאובדן הכרה ולנזק בלתי הפיך תוך דקות ספורות.

החייאה מהירה (CPR) יכולה לשמור על זרימת דם בסיסית עד להגעת צוות רפואי.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

מערכת הנשימה

תפקידים עיקריים

- אחראית להכניס חמצן לגוף ולהוציא ממנו פחמן דו-חמצני
- מורכבת מדרכי הנשימה העליונות והתחתונות
- מאפשרת חילוף גזים באלוואולי החיצוני לדם
- התהליך מתחיל בהכנסת האוויר דרך האף או הפה, ממשיך דרך קנה הנשימה, הברונכים, ומגיע לריאות

הריאות - איבר מרכזי

קצב נשימה תקין

מבוגרים: 12-20 נשימות בדקה

תינוקות: 30-60 נשימות בדקה

הריאות מכניסות חמצן לדם ומסלקות פחמן דו-חמצני. תהליך זה מתרחש באלוואולי הריאות.

חוסר תפקוד של הריאות עלול לגרום לחנק ולנזק מוחי, בשל מחסור בחמצן.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

משמעות מצוקה נשימתית

חריגה מקצב נשימה תקין יכולה להצביע על מצוקה נשימתית, מצב מסוכן שדורש טיפול מיידי. חשוב לוודא תפקוד תקין של הריאות והדרכים הנשימתיות כדי למנוע נזק בלתי הפיך לגוף ולמוח.

סיווג רמות הכרה במטופל

הערכת רמת ההכרה היא שלב קריטי בבדיקת מצב הנפגע. השתמש בשיטת **AVPU** לסיווג מהיר.

1

A - Alert (הכרה מלאה)

המטופל ערני ומגיב לכל גירוי בסביבה. הוא יכול לדבר ולהגיב לפקודות ולשאלות.

2

V - Verbal (מגיב לקול)

המטופל מגיב לצלילים או קול, אך ייתכן שהתגובה לא תהיה תמיד ברורה. למשל, הוא עשוי לפתוח עיניים או להזיז, אך לא בהכרח להבין את השאלה או את הפקודה שניתנה.

3

P - Pain (מגיב לכאב)

המטופל לא מגיב לקול. כלומר, כשהוא מקבל גירוי כואב (כמו לחיצה על הטרפזים), הוא יראה סימני תגובה כמו תנועה או שינוי במצב הגוף.

4

U - Unconscious (חוסר הכרה)

המטופל לא מגיב כלל לכל גירוי, לא קול ולא כאב. הוא נמצא במצב של חוסר הכרה מוחלט, ויש צורך לפעול במהירות ולספק טיפול חירום.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

סכמת החייאה למבוגר (CPR)

החייאה היא פעולה מצילת חיים שמטרתה לשמור על זרימת דם למוח עד להגעת עזרה רפואית. **כל דקה קריטית!**

1

בדיקת בטיחות

וודא שהסביבה בטוחה לפעולה - אין סכנה של חשמל, אש או כלי רכב. הגן על עצמך תחילה.

2

בדיקת הכרה

קרא לנפגע בקול רם ונסה לעורר אותו על ידי טלטול עדין של הכתפיים או צביטה. לבדיקת רמות הכרה עיין בעמוד 9

3

בדיקת נשימה

בדוק אם הנפגע נושם על ידי התבוננות בתנועות החזה והרגשת נשיפה. אם הנפגע לא נושם - התחל בהחייאה מיידית.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

בדיקת בטיחות

שלב ראשון בהחייאה

וודא שהסביבה בטוחה לפעולה - אין סכנה של חשמל, אש או כלי רכב. הגן על עצמך תחילה.

- בדוק אם יש סכנת חשמל באזור
- וודא שאין סכנת אש או עשן
- היזהר מתנועת כלי רכב
- אם המקום מסוכן - פנה את הנפגע למקום בטוח

בדיקת הכרה

שלב שני בהחייאה

קרא לנפגע בקול רם ונסה לעורר אותו על ידי טלטול עדין של הכתפיים או צביטה.

- קרא לנפגע בקול רם: "אתה בסדר?"
- טלטל בעדינות את הכתפיים
- צבוט בעדינות אם אין תגובה
- אם אין תגובה - הנפגע מחוסר הכרה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

בדיקת נשימה

שלב שלישי בהחייאה

בדוק אם הנפגע נושם על ידי התבוננות בתנועות החזה והרגשת נשיפה. אם הנפגע לא נושם - התחל בהחייאה מיידית.

- הטה את ראש הנפגע לאחור כדי לפתוח את דרכי הנשימה
- התבונן בתנועות החזה - האם הוא עולה ויורד?
- הקשב לקולות נשימה
- הרגש נשיפה על הלחי שלך
- בדוק למשך 10 שניות לכל היותר
- אם אין נשימה תקינה - התחל החייאה מיידית!

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

הזעקת עזרה

שלב רביעי בהחייאה

לאחר שזיהית שהנפגע אינו נושם, הזעק עזרה רפואית מיידית והתחל בהחייאה.

- התקשר מיידית למוקד 101
- אם יש אנשים נוספים - בקש מהם להתקשר
- דווח על המצב: אדם מחוסר הכרה שאינו נושם
- ציין את המיקום המדויק
- אל תנתק עד שיורו לך
- אם אתה לבד - התחל החייאה תחילה ואז התקשר
- בקש מישהו להביא דפיברילטור (AED) אם זמין

התחלת עיסויי חזה

שלב חמישי בהחייאה

לאחר שזיהית שהנפגע אינו נושם, הזעק עזרה רפואית מיידית והתחל בהחייאה.

לאחר הזעקת העזרה, התחל מיידית בעיסויי חזה. זהו השלב הקריטי ביותר בהחייאה.

- הנח את כף יד אחת במרכז החזה, בין הפטמות
- הנח את כף היד השנייה מעל הראשונה
- שלב את האצבעות והרם אותן מהחזה
- שמור על זרועות ישרות ומרפקים נעולים
- לחץ בעומק של 5-6 ס"מ
- בצע 100-120 לחיצות לדקה
- אפשר לחזה לחזור למצבו המלא בין לחיצות
- המשך עד הגעת העזרה הרפואית

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

טכניקת עיסויי חזה נכונה

מיקום הידיים

- הנח את כף יד אחת במרכז החזה, בין הפטמות
- הנח את כף היד השנייה מעל הראשונה
- שלב את האצבעות והרם אותן מהחזה
- שמור על זרועות ישרות ומרפקים נעולים

ביצוע הלחיצות

- **עומק:** 5-6 ס"מ
- **קצב:** 100-120 לחיצות לדקה
- אפשר לחזה לחזור למצבו המלא בין לחיצות
- מזער הפסקות בעיסויים

טיפ חשוב

כדי לשמור על קצב נכון של 100-120 לחיצות לדקה, אפשר לחשוב על השיר "Stayin' Alive" או לספור בקצב מהיר. **עיסויים איכותיים הם המפתח להצלחת ההחייאה!**

סימנים לעיסויים יעילים

- החזה יורד בעומק מספיק (5-6 ס"מ)
- הקצב נשמר קבוע
- המטפל לא עייף מדי (החלף מטפלים כל 2 דקות במידת האפשר)

מתי להפסיק החייאה?

המשך בעיסויי חזה עד שאחד מהמצבים הבאים מתרחש:

הנפגע מראה סימני חיים

הנפגע מתחיל לנשום באופן תקין, זז או מראה סימני הכרה

הגעת צוות רפואי

צוות מד"א או רופא הגיעו למקום ולקחו על עצמם את הטיפול

אתה במצב של סכנה

הסביבה הפכה למסוכנת או שאתה במצב של תשישות קיצונית

דפיברילטור מחובר

דפיברילטור הגיע והוחבר לנפגע - עקוב אחר הנחיות המכשיר

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

דגש קריטי

אל תוותרו! גם אם נראה שההחייאה לא עובדת, המשך בעיסויים. אתה שומר על זרימת דם מינימלית למוח, מה שיכול להציל חיים. סטטיסטיקות מראות שהחייאה מיידית מכפילה ואף משלשת את סיכויי ההישרדות.

החייאת ילד (מגיל 1 עד גיל 8)

עקרונות כלליים

הגדרת גיל: ילד מוגדר מגיל שנה ועד גיל 8 שנים. מבחינת הסכימה אין שוני מהותי בין החייאת מבוגר להחייאת ילד.

התייחסות לאנטומיה

חשוב להתייחס להבדלים האנטומיים הקיימים בין ילדים למבוגרים: גודל הגוף הקטן יותר, מבנה בית החזה העדין יותר, גמישות רבה יותר של כלוב הצלעות

עזרה ראשונה | **החייאה** | חנק | מצבי חירום | טראומה

דגשים מיוחדים בהחייאת ילד

- **שימוש ביד אחת:** בהחייאת ילד יש להשתמש ביד אחת כדי לבצע עיסוי לבבי
- **עומק עיסוי הלב:** יש ללחוץ בעומק של 3-4 ס"מ (לא 5-6 ס"מ כמו במבוגרים)
- **קצב:** 100-120 לחיצות לדקה (זהה למבוגרים)

זכור: הסכימה זהה למבוגרים: בדיקת בטיחות ← בדיקת הכרה ← בדיקת נשימה ← צלצול למד"א ← עיסויים. לסכימה המלאה עיין בעמוד 10

החייאת תינוקות (עד גיל שנה)

סדר פעולות החייאה בתינוקות

1. **בדיקת בטיחות** - וודא שהסביבה בטוחה ונטולת סכנות
2. **בדיקת הכרה** - קרא לתינוק בשמו, טפח עדין על גבו או דגדג בכפות הרגליים
3. **בדיקת נשימה** - התבונן בתנועות החזה, הקשב לקולות נשימה או הרגש נשיפה
4. **צלצול למד"א** - התקשר מיד ל-101 ובקש דפיברילטור

טכניקת עיסויים לתינוקות

מיקום ועומק

- השתמש ב-2 אצבעות במרכז החזה
- עומק לחיצה: כ-4 ס"מ (שליש עומק החזה)
- קצב: 100-120 לחיצות לדקה

משטח עבודה

- בצע החייאה על משטח קשיח
- לא על מיטה, ספה או משטח רך
- זאת כדי להבטיח שהלחיצות יהיו אפקטיביות

הדבקת דפיברילטור על תינוק

מיקום המדבקות

מדבקה על החזה

הדבק מדבקה אחת על החלק התחתון של החזה של התינוק

מדבקה על הגב

הדבק מדבקה שנייה על גב התינוק, באזור התחתון, כך שהיא ממוקמת בין השכמות

המשך טיפול

- בצע עיסויים בעזרת 2 אצבעות במרכז החזה של התינוק
- שמור על קצב של 100 עד 120 לחיצות בדקה
- המשך לבצע עיסויים עד הגעת צוות רפואי או עד שהתינוק חוזר לנשום
- השאר את הדפיברילטור מחובר לכל אורך פעולות ההחייאה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

דגשים חשובים בהחייאת תינוק

- **ביצוע החייאה:** על משטח קשיח בלבד
- **כוח הלחיצה:** שתי אצבעות במרכז החזה
- **חיבור דפיברילטור:** השאר מחובר לאורך כל ההחייאה
- **פעולה מהירה:** הזמן שלוקח לפעול יכול להשפיע על סיכויי ההישרדות

עזרה ראשונה | **החייאה** | חנק | מצבי חירום | טראומה

ציוד רפואי בהחייאה

דפיברילטור (AED)

מכשיר אוטומטי למתן שוק חשמלי

מסכת כיס

למתן הנשמות בטוחות

כפפות חד-פעמיות

להגנה אישית

מספריים רפואיים

לחיתוך בגדים במידת הצורך

תחבושות סטריליות

לטיפול בפצעים

מזרק אפינפרין

למקרי שוק אנפילקטי

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

דפיברילטור (AED)

דפיברילטור הוא מכשיר רפואי חיוני במצבי חירום, שמטרתו העיקרית היא לספק שוק חשמלי כחלק מתהליך ההחייאה.

שוק חשמלי

תפקיד השוק החשמלי הוא לאפס את הלב במצב של פרפור חדרים, שבו הלב לא מצליח לפעול בצורה תקינה

הנחיות קוליות

המכשיר מלווה את המטפל שלב אחר שלב במהלך ההחייאה, ומעניק הנחיות קוליות ברורות כדי להנחות את הפעולה הנדרשת

שיפור סיכויי הישרדות

באמצעות השוק, הדפיברילטור מאפשר למטפלים לבצע עיסויים בצורה הרבה יותר יעילה, ובכך להגדיל את הסיכוי להחזרת זרימת הדם התקינה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

חנק מגוף זר - הגדרה

חנק מגוף זר הוא מצב שבו גוף זר חוסם את קנה הנשימה. זהו מקרה שכיח, בעיקר בקרב תינוקות (הכנסת חפצים לפה) ומבוגרים (השתנקות מפיסות אוכל). במקרים חמורים, החנק יכול להוביל למצב מסכן חיים.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

איך נזהה מצב של חנק?

- **סיפור מקרה:** ילד בחדר שבו יש חפצים קטנים או סצנה דומה
- **תנועה אופיינית:** אדם אוחז בגרונו (סימן אוניברסלי לחנק)
- **צבע עור:** מאפיר או מכחיל
- **השתנקות:** נפגע משתנק ולא מצליח לנשום בצורה יעילה

סוגי חסימות בחנק

חסימה חמורה

נתיב האוויר חסום לחלוטין

סימנים:

- לא יכול להשתעל - השיעול מגיע מהריאות, ובחסימה מוחלטת לא ניתן להשתעל
- לא יכול להוציא קול או לבכות - חסימת מיתרי הקול לא מאפשרת השמעת קול
- אוחז בגרון
- פנים מכחילות

דורש טיפול מיידי!

חסימה חלקית

נתיב האוויר חסום באופן חלקי

סימנים:

- יכול להשתעל בצורה חזקה
- יכול לדבר או לבכות
- מסוגל להוציא קולות
- נושם, אך בקושי

עודד השתעלות

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

עיקרון חשוב

אם האדם יכול להשתעל, לדבר או לבכות - זו חסימה חלקית. אם הוא לא יכול לעשות אף אחד מאלה - זו חסימה חמורה הדורשת פעולה מיידית.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

טיפול בחסימה חמורה - תמרון היימליך

סדר פעולות

1. **הזעקת עזרה** - התקשר מיידית למד"א (101)
2. **מיקום המטפל** - עמוד מאחורי הנפגע, כשגובה המטפל מתאים לגובה הנפגע. במידת הצורך, פתח את רגליך ליציבות
3. **תנוחת הידיים** - קפל את האצבעות לאגרוף כשהאגודל מופנה כלפי חוץ
4. **ביצוע לחיצות** - בצע לחיצות חזקות ומהירות כלפי פנים ומעלה בחלק הבטן העליון, מתחת לצלעות

דגש חשוב בתמרון הַיימליך

המשך בלחיצות עד שהגוף הזר יוצא, הנפגע מתחיל לנשום, או עד שהנפגע מאבד הכרה. אם הנפגע מאבד הכרה - התחל בהחייאה מיידית.
לסכימת החייאה עיין בעמוד 10

מקרים מיוחדים בחנק

נפגע בכיסא גלגלים

יש לקבע את הכיסא (נעל את הבלמים), לבוא מאחורי ולבצע לחיצות בחלק הבטן כרגיל.

נשים בהריון

יש לבצע לחיצות על בית החזה במקום הבטן העליונה. מקם את האגרוף במרכז החזה ובצע לחיצות חזקות כלפי פנים.

חסימה חמורה ללא הכרה

יש להתחיל בהחייאה מיידית. העיסויים עוזרים לדחוף את הגוף הזר החוצה. עיין בעמוד 10

אדם כבד משקל מאוד

ניתן לבצע דחיקות כנגד קיר. הנפגע נשען על הקיר והמטפל מבצע לחיצות מלפנים.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

מה אסור לעשות

- אין למצוץ את הגוף הזר
- אין להכניס אצבעות לפה אלא אם רואים את הגוף הזר בבירור
- אין לתת מים לשתייה בחסימה חמורה

טיפול בחסימה חלקית

בחסימה חלקית, הנפגע עדיין יכול לנשום, להשתעל ולהוציא קולות. המטרה היא לעזור לו להוציא את הגוף הזר בעצמו.

1. **הושב את הנפגע** - הושב את הנפגע במצב נוח וזקוף
2. **עודד השתעלות** - עודד את הנפגע להשתעל בכוח. השיעול הוא הדרך הטבעית והיעילה ביותר להוציא גוף זר
3. **הרגע את הנפגע** - דבר ברוגע והרגע את הנפגע. מתח וחרדה מחמירים את המצב
4. **הצע שתיית ממים** - ניתן להציע שתיית ממים בלגימות קטנות, אך רק אם הנפגע יכול לבלוע
5. **עקוב אחר המצב** - אם המצב מחמיר והופך לחסימה חמורה - פעל מיידית לפי הנחיות חסימה חמורה

מדדים חיוניים

מדדים חיוניים הם מדידות בסיסיות של תפקודי הגוף החיוניים. הם עוזרים להעריך את מצב הנפגע ולזהות בעיות רפואיות.

נשימה (Respiration)

מספר נשימות לדקה. מעיד על תפקוד מערכת הנשימה.

תקין במבוגרים: 12-20 לדקה

תקין בתינוק: 30-60 לדקה

דופק (Pulse)

מספר פעימות הלב לדקה. מעיד על תפקוד הלב וזרימת הדם.

תקין במבוגרים: 60-100 לדקה

תקין בתינוק: 100-160 לדקה

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

מדדים חיוניים נוספים

טמפרטורת גוף

חום הגוף. מעיד על זיהומים או מצבי סביבה קיצוניים.

תקין: 36.5-37.5 מעלות צלזיוס

לחץ דם (Blood Pressure)

הלחץ בכלי הדם. מורכב משני ערכים: סיסטולי ודיאסטולי.

תקין: 110-140 / 70-90 מ"מ כספית

מדידת מדדים חיוניים עוזרת לזהות שינויים במצב הנפגע ולקבוע את דחיפות הטיפול הרפואי. תעד את המדידות והעבר אותן לצוות הרפואי.

עזרה ראשונה | החייאה | חנק | מצבי חירום | טראומה

מבוא לטראומה

טראומה היא פגיעה פיזית בגוף הנגרמת כתוצאה מכוח חיצוני, תאונה, נפילה או אלימות.
טראומה יכולה להיות קלה או חמורה, ולעיתים מסכנת חיים.

סוגי טראומות עיקריים:

- טראומה קהה - מכה, נפילה, תאונת דרכים
- טראומה חודרת - דקירה, ירי
- כוויות
- שברים
- פציעות ראש

סוגי דימום

דימום הוא איבוד דם מכלי הדם. דימום יכול להיות חיצוני (נראה) או פנימי (לא נראה).

דימום עורקי

דם אדום בהיר, זורם בפולסים, מסוכן ביותר

דימום ורידי

דם אדום כהה, זורם בצורה רציפה

דימום נימי

דם מחלחל לאט, פחות מסוכן

סכנות דימום:

- אובדן דם רב עלול להוביל להלם
- ירידה בלחץ דם
- אובדן הכרה
- סכנת חיים

טיפול בדימום חיצוני

עקרונות טיפול בדימום:

לחץ ישיר

הפעל לחץ ישיר על מקום הדימום באמצעות חבישה סטרילית או בד נקי

הרמה

הרם את האיבר הפצוע מעל רמת הלב (אם אין חשד לשבר)

לחץ על נקודת לחץ

אם הדימום לא נעצר, הפעל לחץ על נקודת הלחץ העורקית הקרובה

חוסם עורקים (טורניקט)

רק במקרים קיצוניים של דימום מסיב שלא ניתן לעצור

חשוב לזכור:

- אל תסיר חבישה ספוגה בדם - הוסף חבישה נוספת מעליה
- הזעק עזרה רפואית מיידית במקרה של דימום חמור

שברים - זיהוי וטיפול

שבר הוא שבירה או סדק בעצם. שברים יכולים להיגרם מנפילה, מכה, תאונה או מחלה.

סימני שבר

כאב עז
באזור הפגיעה

נפיחות ושטף דם

עיוות
או דפורמציה של האיבר

חוסר יכולת
להזיז את האיבר

צליל חריקה
(קרפיטציה)

סוגי שברים

- **שבר סגור** - העצם שבורה אך העור שלם
- **שבר פתוח** - העצם בולטת מהעור (מסוכן יותר)

עקרונות טיפול

1. **אל תזיז את האיבר הפצוע**
2. **קבע את האיבר** במצבו הנוכחי
3. **הנח קרח** לצמצום נפיחות
4. **הזעק עזרה רפואית**

הזעק עזרה רפואית
התקשר למד"א 101

קבע את האיבר
במצבו הנוכחי

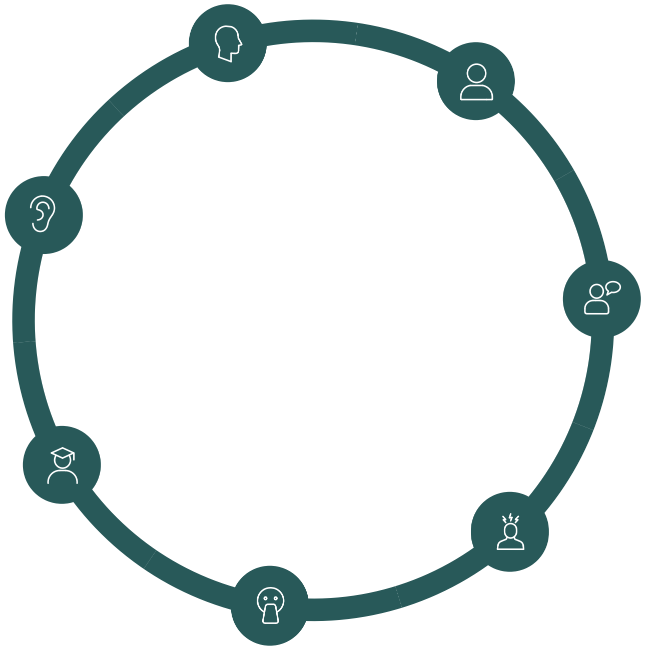
אל תזיז את האיבר
מנע תנועה כדי למנוע נזק נוסף

הנח קרח
לצמצום נפיחות

פציעות ראש

פציעות ראש יכולות להיות מסוכנות ביותר בשל הסיכון לפגיעה במוח.

סימני פציעת ראש חמורה:



אובדן הכרה

(גם לזמן קצר)

פגיעה בראייה או בדיבור

כאב ראש עז

ומתמשך

בלבול, סחרחורת או חולשה

דימום או נוזל

מהאוזניים או האף

אישונים בגדלים שונים

הקאות חוזרות

טיפול בפציעת ראש:

1. **שמור על נפגע** בשכיבה עם הראש מוגבה מעט
2. **אל תזיז** את הראש או הצוואר אם יש חשד לפגיעה בעמוד השדרה
3. **עצור דימום** בלחץ עדין (לא ישיר על שבר גולגולת)
4. **הזעק עזרה רפואית** מיידית

חשוב: כל פציעת ראש דורשת בדיקה רפואית!

כוויות - דרגות וטיפול

כוויה היא פגיעה ברקמת העור והרקמות שמתחת לה, הנגרמת מחום, חשמל, כימיקלים או קרינה.

דרגות כוויות:

כוויה מדרגה ראשונה

- נזק לשכבה החיצונית של העור בלבד
- אדמומיות וכאב
- ללא שלפוחיות
- דוגמה: כוויית שמש קלה

כוויה מדרגה שנייה

- נזק לשכבות עמוקות יותר של העור
- שלפוחיות, אדמומיות וכאב עז
- דוגמה: כוויה מנוזל רותח

כוויה מדרגה שלישית

- נזק לכל שכבות העור ולרקמות מתחת
- העור נראה לבן, חום או שחור
- אובדן תחושה (עצבים נפגעו)
- מסכנת חיים - דורשת טיפול רפואי מיידי

עקרונות טיפול בכוויות:

1. **הרחק** את הנפגע ממקור הכוויה
2. **קרר** את הכוויה במים זורמים (10-20 דקות)
3. **כסה** בחבישה סטרילית
4. **אל תפרוץ** שלפוחיות
5. **הזעק** עזרה רפואית לכוויות חמורות

הלם (Shock) - זיהוי וטיפול

הלם הוא מצב מסכן חיים שבו מערכת הדם אינה מספקת מספיק חמצן לאיברים החיוניים.

גורמי הלם:

- דימום חמור
- התייבשות
- זיהום (ספסיס)
- תגובה אלרגית חמורה (אנפילקסיס)
- פגיעה בלב

סימני הלם:

- עור חיוור, קר ולח
- דופק מהיר וחלש
- נשימה מהירה ורדודה
- חולשה וסחרחורת
- בלבול או אובדן הכרה
- בחילות והקאות

טיפול בהלם:

- הזעק עזרה רפואית מיידית (101)
- השכב את הנפגע על הגב
- הרם את הרגליים
  (אם אין חשד לשבר)
- שמור על חום הגוף
- אל תיתן מזון או משקה
- עקוב אחר מצבו עד הגעת העזרה

חשוב: הלם הוא מצב חירום רפואי - פעל מהר!

תודה רבה!

תודה שהייתם איתנו

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו: 053-3111505